

OS 3 D — DELIRIUM É EMERGÊNCIA

OS TRÊS D — DIFERENCIAÇÃO

Aspecto	Delirium	Demência	Depressão
Início	Agudo (horas-dias)	Insidioso (meses-anos)	Subagudo (semanas)
Curso	Flutuante, piora à noite	Progressivo e estável no dia	Persistente, pior pela manhã
Atenção	Gravemente prejudicada	Preservada (fases iniciais)	Pode estar reduzida
Consciência	Alterada (hipo ou hiperalerta)	Normal (até fases avançadas)	Normal
Reversibilidade	Reversível (tratar a causa)	Geralmente irreversível	Reversível com tratamento
Pista-chave	Procurar causa orgânica aguda	Declínio cognitivo crônico	Humor deprimido, anedonia

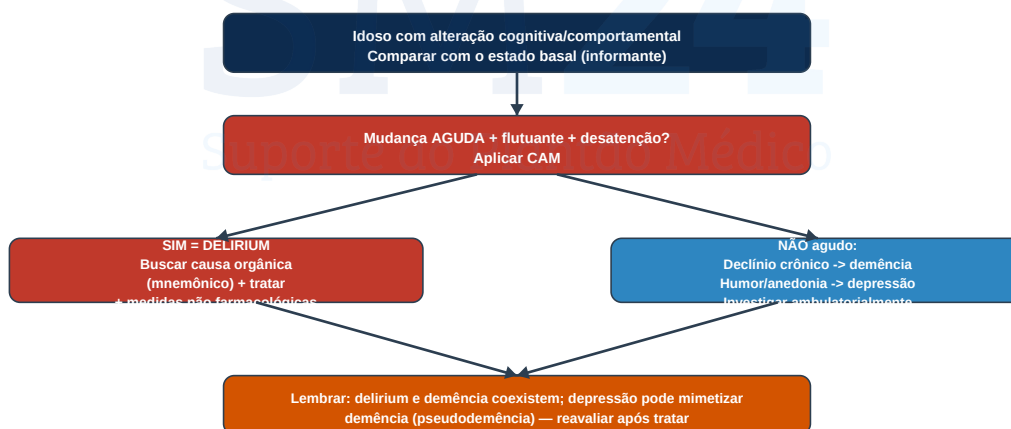
DELIRIUM É UMA EMERGÊNCIA MÉDICA

MUDANÇA AGUDA DO ESTADO MENTAL = BUSCAR CAUSA

- Delirium = disfunção cerebral aguda secundária a uma causa orgânica (não é 'própria da idade')
- Associado a maior mortalidade, internação prolongada e declínio funcional
- Subtipos: hiperativo (agitado), hipoativo (sonolento — mais comum e mais subdiagnosticado) e misto
- Diagnóstico com o CAM: (1) início agudo e curso flutuante + (2) desatenção + (3 OU 4) pensamento desorganizado OU alteração do nível de consciência
- Sempre investigar a causa: a abordagem é tratar o gatilho, não apenas sedar
- Demência é o principal fator de risco — delirium frequentemente se sobrepõe à demência

ABORDAGEM DA ALTERAÇÃO MENTAL NO IDOSO

MUDOU AGUDAMENTE? PENSE EM DELIRIUM



CAUSAS DE DELIRIUM — MNEMÔNICO 'I WATCH DEATH'

Letra	Categoria	Exemplos
I	Infecção	ITU, pneumonia, sepse (causas muito comuns no idoso)
W	Withdrawal	Abstinência de álcool/benzodiazepínico
A	Aguda metabólica	Distúrbios de Na/K/Ca, glicemia, acidose
T	Trauma/Toxinas	TCE, medicamentos (anticolinérgicos, opioides, BZD)
C/H	SNC / Hipóxia	AVC, HSA, meningite; hipóxia, IAM, anemia
D/D/E/A/TH	Deficiências, endócrino, agudo vascular, metais pesados	Tiamina/B12; tireoide; retenção urinária/fecaloma; intoxicações

MANEJO DO DELIRIUM

Medidas Não Farmacológicas (1a linha)

- Tratar a causa de base é o pilar (infecção, droga, distúrbio metabólico, retenção/fecaloma)
- Reorientação, relógio/calendário, presença de familiar
- Restaurar ciclo sono-vigília; reduzir ruído noturno
- Mobilização precoce, retirar sondas/cateteres desnecessários
- Garantir óculos e aparelhos auditivos; hidratação e nutrição
- Revisar e suspender fármacos deliriogênicos (anticolinérgicos, BZD)

Quando Usar Medicação

- Apenas se agitação com risco para o paciente/equipe e falha das medidas não farmacológicas
- Haloperidol em dose baixa (0,25-0,5 mg) é a opção mais usada; cuidado com QT e sintomas extrapiramidais
- Antipsicótico atípico (quetiapina) em parkinsonismo/corpos de Lewy
- EVITAR benzodiazepínico (piora o delirium) — exceto na abstinência alcoólica/BZD
- Reavaliar diariamente e suspender assim que possível
- Contenção física é último recurso (aumenta agitação e lesão)

ABORDAGEM PRÁTICA NO PS

PONTOS-CHAVE

- ☐ Estabelecer o estado mental BASAL com um informante
- ☐ Aplicar o CAM; lembrar do delirium hipoativo (sonolento, passa despercebido)
- ☐ Investigar causa: exame físico, glicemia, eletrólitos, função renal, urina/EAS, hemograma, ECG; imagem se indicado
- ☐ Checar fármacos, retenção urinária (bexigoma) e fecaloma — causas reversíveis frequentes
- ☐ Tratar a causa + medidas não farmacológicas como base
- ☐ Antipsicótico em dose baixa só se agitação de risco; evitar benzodiazepínico (exceto abstinência)

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Idoso com início agudo de confusão flutuante e desatenção, após internação por pneumonia. Qual o diagnóstico mais provável e a conduta principal?

- A) Demência de Alzheimer — iniciar anticolinesterásico
- B) Delirium — investigar e tratar a causa (a pneumonia/infecção) e aplicar medidas não farmacológicas
- C) Depressão — iniciar antidepressivo
- D) Surto psicótico — antipsicótico em dose alta
- E) Envelhecimento normal — apenas observar

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual característica diferencia melhor o delirium da demência?

- A) A idade do paciente
- B) O início agudo com curso flutuante e a desatenção marcante do delirium
- C) A presença de déficit de memória
- D) A ausência de alucinações
- E) O nível de escolaridade

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Qual classe de medicamentos deve ser EVITADA no tratamento do delirium (exceto na abstinência alcoólica)?

- A) Antipsicóticos típicos em dose baixa
- B) Benzodiazepínicos
- C) Antibióticos
- D) Analgésicos simples
- E) Antipsicóticos atípicos

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Idosa com queixa de 'perda de memória' há semanas, humor deprimido, anedonia e respostas 'não sei', com melhora cognitiva após tratamento do humor. Qual o quadro?

- A) Demência avançada irreversível
- B) Pseudodemência depressiva (depressão mimetizando demência)
- C) Delirium hiperativo
- D) Esquizofrenia tardia
- E) Doença de Parkinson

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Qual é a base do tratamento do delirium?

- A) Sedação contínua com benzodiazepínico
- B) Identificar e tratar a causa orgânica + medidas não farmacológicas
- C) Contenção física precoce
- D) Antipsicótico em dose alta para todos
- E) Alta precoce para o domicílio

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Início agudo de confusão flutuante com desatenção em paciente com infecção (pneumonia) caracteriza delirium. A conduta principal é investigar e tratar a causa (infecção) e aplicar medidas não farmacológicas — não apenas sedar.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

O delirium se distingue da demência pelo início AGUDO, curso FLUTUANTE e desatenção marcante, com alteração do nível de consciência. A demência tem início insidioso e curso crônico, com atenção preservada nas fases iniciais.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Os benzodiazepínicos pioram o delirium e devem ser evitados, exceto quando a causa é abstinência de álcool ou de benzodiazepínico. Quando é necessário medicar a agitação de risco, prefere-se antipsicótico em dose baixa (ex.: haloperidol).

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Quadro de declínio cognitivo associado a humor deprimido e anedonia, com respostas 'não sei' e melhora após tratar o humor, caracteriza pseudodemência depressiva — a depressão pode mimetizar demência no idoso e é reversível.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A base do tratamento do delirium é identificar e tratar a causa orgânica (infecção, droga, distúrbio metabólico, retenção/fecaloma) associada a medidas não farmacológicas (reorientação, sono, mobilização). Medicação é reservada para agitação de risco.

SM24
Suporte ao Plantão Médico